



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RSUD Dr. SOETOMO

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

RSUD DR. SOETOMO SURABAYA





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Surabaya, Telepon 031-550 1078, Fax 5028735, Kode Pos 60286
Website www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id, E-mail kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
NOMOR : 100.3.3 / 5763.1 / 102.6 / 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas, agar masyarakat yang dilayani dapat memperoleh tindakan medis, pengobatan dan perawatan yang optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan keberadaan rumah sakit, perlu adanya standar untuk terjaminnya upaya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan perkembangan pelayanan, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan pelayanan dan dalam rangka optimalisasi berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan kembali Keputusan tentang Standar Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknik Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/438/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dalam memberikan pelayanan;
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor 188.4/15368.8/102.6/2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A

PADA TANGGAL : 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD Dr. SOETOMO



Tembusan:

1. Para Wakil Direktur
2. Yang Bersangkutan

1. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Aspek	Uraian
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum: a. Kartu berobat pasien (untuk pasien lama yang sudah memiliki kartu) b. Kartu identitas pasien 2. BPJS/asuransi lain: a. Kartu BPJS/asuransi lain b. Menunjukkan kartu identitas c. Surat rujukan dari faskes perujuk (jika ada) 3. Pasien terlanjar: pasien tetap terlayani sesuai dengan penyakit yang ditemukan Pasien yang dilayani adalah pasien dengan kegawatdaruratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien dan keluarga diterima oleh petugas di area drop zone, masuk melalui pintu utama, apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda dan brankart, petugas siap mengantar masuk IGD, dan keluarga mendaftarkan pasien di bagian admisi. 2. Pasien diterima di ruang triage dan dilakukan <i>primary survey</i> oleh dokter bersama perawat triage untuk menentukan label, (Hijau, Kuning, Merah, Biru), apabila ditemukan kegawatn dilakukan langkah tindakan pertolongan A, B, C. Selama masa pandemi covid-19, seluruh pasien yang masuk di IGD dilakukan skrining covid-19. 3. Berdasarkan hasil skrining covid-19: 1) Jika pasien mengarah ke klinis covid-19, pasien akan ditempatkan di ruang IGD Menular. 2) Untuk pasien yang tidak mengarah ke klinis covid-19 ditempatkan di ruang tindakan sesuai label. 4. Pasien/Keluarga Pasien melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran IGD setelah ditetapkan tingkat kegawatdaruratannya a. Pasien Baru : 1) Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/ KK /Paspor) 2) Entri data sosial pasien untuk menerbitkan nomor rekam medis b. Pasien Lama:

		1) Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/ KK /Paspor) 2) Entri nomor rekam medis pasien c. Pasien Penjaminan 1) Petugas Pendaftaran IGD meminta Identitas Penjaminan Pasien 2) Petugas Pendaftaran ID mencetak surat jaminan pelavanoan 5. Petugas Pendaftaran ID menginput Data Sosial Pasien sesuai dengan KTP/KK/Paspor ke dalam Sistem Informasi Rumah Sakit 6. Petugas Pendaftaran ID mencetak barcode Identitas Pasien. 7. Petugas Pendaftaran ID mencetak Gelang Identitas Pasien 8. Petugas Pendaftaran IGD mengarahkan pasien untuk membaca Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Pasien pada Media Informasi Rumah Sakit 9. Untuk selanjutnya baik yang di ruang isolasi maupun di zona tindakan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan 10. Hasil skrining, anamnesis, pemeriksaan fisik dan TTV yang dilakukan oleh perawat bersama dokter didokumentasikan pada Formulir Asesmen Gawat Darurat, termasuk hasil pemeriksaan penunjang dilampirkan. 11. Pasien akan dilakukan tindakan sesuai dengan indikasi. 12. Apabila diperlukan konsul ke dokter konsultan bidang lain 13. Setelah observasi pasca tindakan beberapa keputusan tentang tindak lanjut pasien: 1) Pasien bisa pulang untuk rawat jalan. - Pasien diberikan resep obat untuk diminum di rumah. - Keluarga menyelesaikan administrasi di bagian administrasi. - Petugas IGD membuatkan pengantar untuk kontrol ke rawat Jalan, untuk pasien BPJS meminta rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat I terlebih dahulu. - Petugas memberikan edukasi untuk perawatan di rumah. - Pasien pulang dengan menyertakan kartu kontrol, pengantar rawat jalan, dan hasil pemeriksaan penunjang.
--	--	--

		2) Pasien menjalani rawat inap. - Petugas IGD memberikan pengantar kepada keluarga untuk pemesanan kamar di bagian admisi. - Petugas admisi menjelaskan tentang general konsen kepada keluarga termasuk ruang yang akan dituju. - Keluarga menandatangani persetujuan. - Pasien diantar petugas IGD ke ruangan yang dituju. 3) Pasien dirujuk. - Petugas IGD memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang alasan dan tujuan dilakukan rujukan. - Petugas IGD melakukan konfirmasi ketersediaan layanan ke Rumah Sakit tujuan rujukan. - Petugas IGD menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk rujukan. - Petugas IGD menyiapkan tenaga perujuk. - Petugas IGD mendampingi pasien selama proses rujukan. 4) Pasien meninggal di UGD. - Petugas IGD merawat jenazah sesuai dengan prosedur. - Petugas IGD mengantarkan jenazah ke Instalasi Kedokteran Forensik untuk perawatan lanjutan jika diperlukan atau untuk proses pemulangan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Administrasi/pendaftaran pelayanan gawat darurat dilakukan setiap hari Senin - Minggu dalam waktu 24 jam
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Jasa Konsultasi Rawat Jalan IGD Rp 50.000,- - Jasa Konsultasi Triage Rp 25.000,-
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Medis Gawat Darurat Bedah dan Non Bedah sesuai spesialisasi 2. Pelayanan Kamar Operasi 3. Pelayanan Intensif (ICU/ROI, NICU) 4. Pelayanan Kegawat daruratan Obstetri 5. Pelayanan Radiologi

		6. Pelayanan Laboratorium 7. Pelayanan Farmasi
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1. Website/SANDI : https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 2. Facebook : RSUD Dr. Soetomo 3. Twitter : @rsudrsoetomo 4. Instagram : @rsudrsoetomo 5. No. Telp IGD : 0315501299
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	1. Undang Uundang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang -Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 3. Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. 4. Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 5. Permenkes No. 30 tahun 2020 Kualifikasi Perijinan Rumah Sakit.
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu pasien + musholla + toilet 2. Ruang Admisi. 3. Loker Administrasi. 4. Ruang Farmasi 24 jam. 5. Bank Darah. 6. Sarana <i>hand washing</i> dan <i>hand rub</i> . 7. Ruang Triase. 8. Ruang Perawatan menular dan non menular 9. Ruang Resusitasi 10. Ruang Operasi 11. Ruang Intensif Care 12. Ruang Tindakan. 13. Ruang Kantor. 14. Nurse Station. 15. Ruang Dokter Jaga. 16. Ruang X Ray, CT Scan. 17. Ruang laboratorium.

9	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Instalasi: dokter spesialis (Sertifikat PPGD/ACLS) 2. Ka Keperawatan: S-1 (Sertifikat PPGD/BLS) 3. Dokter Jaga Triage: dokter umum (Sertifikat PPGD/ACLS) 4. Dokter Jaga Kelompok Staf Medis: dokter spesialis 5. Perawat Pelaksana: D III Keperawatan (Sertifikat PPGD/BLS) 6. Petugas Pengambil Contoh: SLTA terlatih (BLS, komunikasi efektif) 7. Frontliner: IPMS (<i>Sertifikat Customer Service</i>)
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum: 8 2. Perawat: 217 3. Bidang: 28 4. Pengambil contoh: 33 5. Pramu bakti: 23
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien baru: a. Petugas pendaftaran rawat jalan meminta pasien mengisi Kartu Identitas Berobat; b. Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/KK/Paspor); c. Entry data sosial pasien untuk menerbitkan nomor rekam medis. 2. Pasien lama: a. Petugas pendaftaran rawat jalan mmeinta pasien menunjukkan Kartu Identitas Berobat; b. Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/KK/Paspor); c. Entri nomor rekam medis pasien; d. Petugas pendaftaran rawat jalan meminta salinan resume medis untuk pasien pasca rawat inap, atau melihat surat kontrol pada Sistem Informasi Rumah Sakit.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Bulanan IGD 1. Laporan Jumlah Kunjungan 2. Laporan Persalinan 3. Laporan Kegiatan Rujukan

	4. Laporan Vaksin Bayi Hb 5. Laporan Kesehatan Bayi 6. Laporan Respon Time SC Emergency 7. Laporan Utilitas Kamar Operasi 8. Laporan Jenis/Macam Operasi 9. Laporan Indikator Kinerja Rawat Inap 10. Laporan Data Pasien > 6jam 11. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 12. Laporan Kepuasan Pelanggan 13. Laporan Indikator Mutu Unit 14. Laporan Insiden
--	---

2. PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Aspek	Uraian
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan	- Pasien Umum/Mandiri: - Pasien datang di pendaftaran dengan dengan membawa kartu identitas seperti KTP, SIM. - Pasien yang pembayaran dengan jaminan harus membawa rujukan dari faskes pertama seperti puskesmas/dokter keluarga/faskes I/dokter praktek swasta/RS - Pasien BPJS PBI/ BPJS Non PBI: - Pasien rujuk - an faskes I/puskesmas/RS - Kartu BPJS - KTP/KK - Pasien baru: Persyaratan seperti diatas - Pasien lama: Kartu kontrol dari RSUD Dr. Soetomo - Bagi pasien HIV (Poli UPIPI) wajib hadir untuk melakukan <i>finger print</i> apabila akan konsultasi dengan DPJP (tidak bisa diwakilkan)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas pendaftaran rawat jalan mengucapkan salam dan melayani pasien atau keluarga pasien sesuai dengan nomor antrian pendaftaran; - Pasien baru: - Petugas pendaftaran rawat jalan meminta pasien mengisi Kartu Identitas Berobat - Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/KK/Paspor) - Entri data sosial pasien untuk menerbitkan nomor rekam medis - Pasien lama: - Petugas pendaftaran rawat jalan meminta pasien menunjukkan Kartu Identitas Berobat - Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/KK/Paspor) - Entri nomor rekam medis pasien - Petugas pendaftaran rawat jalan meminta salinan resume medis untuk pasien pasca rawat inap, atau meliat surat kontrol pada Sistem Informasi Rumah Sakit - Entri poli klinik tujuan

		5. Pasien Umum: - Petugas pendaftaran rawat jalan meminta surat rujukan dari Puskesmas/Dokter Keluarga/RSUD - Petugas pendaftaran rawat jalan mengarahkan pasien untuk menyelesaikan pembayaran administrasi ke kasir rawat jalan 6. Pasien Penjaminan: - Petugas pendaftaran rawat jalan meminta surat rujukan dari Puskesmas/Dokter Keluarga/RSUD - Petugas pendaftaran rawat jalan mencetak surat jaminan pelayanan 7. Petugas pendaftaran rawat jalan mengarahkan pasien untuk membaca hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien pada media informasi rumah sakit 8. Petugas pendaftaran rawat jalan mengarahkan pasien ke poli yang dituju
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Hari senin -kamis pukul 08.00 - 14.00 2. Hari Jumat pukul 08.00 - 14.00 3. Hari sabtu, minggu dan libur nasional tutup
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Rawat Jalan Reguler - Assesmen Personal Reguler Rp. 45.000,- - Jasa Konsultasi Rawat Jalan Rp. 50.000,- - Rawat Jalan Privat - Assesmen Personal Privat Rp. 70.000,- - Honor Dokter Rawat Jalan Spesialis Rp. 250.000,- - Honor Dokter Rawat Jalan Spesialis Rp. 350.000,- - Honor Dokter Rawat Jalan Spesialis Rp. 500.000,- - Rawat Jalan Mandiri - Assesmen Personal Mandiri Rp. 55.000,- - Jasa Konsultasi Poli Mandiri Rp. 145.000,- - Rawat Jalan Eksekutif - Iur Biaya Poli Eksekutif BPJS Rp. 250.000,- - Iur Biaya Poli Eksekutif BPJS – 1 Rp. 250.000,- - Iur Biaya Poli Eksekutif BPJS – 2 Rp. 300.000,-
5	Produk Pelayanan	Semua poliklinik di Instalasi Rawat Jalan
6	Penanganan Pengaduan, saran,	5. Website/SANDI : https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 6. Facebook : RSUD Dr. Soetomo

	dan masukan/apresiasi	7. Twitter : @rsudrsoetomo 8. Instagram : @rsudrsoetomo 9. No. Telp : 031-5501488
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 3. Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. 4. Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 5. Permenkes No. 30 tahun 2020 Kualifikasi Perijinan Rumah Sakit.
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tempat pendaftaran pasien 2. Ruang tunggu: kursi, TV, fotocopy, AC kipas angin, tulisan petunjuk nomor antrian 3. Poliklinik: alkes, ATK, komputer, mikrofon. 4. Ruang pembayaran bank JATIM 5. Anjungan pendaftaran mandiri dan online 6. Kursi roda dan brandcart
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis 2. Dokter umum khusus Klinik general chek up 3. Perawat, bidan, fisioterapi, ahli gizi, psikolog 4. Tenaga non medis 5. IPMS 6. Transporter 7. Cleaning service
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
11	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi: 1 2. Koordinator pelayanan: 1 3. Koordinator mutu: 1 4. Koordinator pendidikan, penelitian, dan pelatihan: 1 5. Koordinator sekretariat: 1 6. Penanggungjawab ruangan: 12 7. Perawat pelaksana: 100 8. Bidan pelaksana: 11 9. Tenaga kesehatan lain: 52

		10. Tenaga administrasi: 57 11. Transporter: 4 12. PRT: 20
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monev Standar Pelayanan Minimal dilakukan setiap bulan 2. Monev pelayanan dilakukan setiap bulan 3. Penilaian kinerja dokter perawat dilakukan 1 bulan sekali 4. Laporan hasil pelayanan dilakukan 1 tahun sekali

3. PELAYANAN GRAHA AMERTA

No	Aspek	Penjelasan
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan	1. Pasien Umum/Mandiri: a. Pasien datang di pendaftaran dengan membawa kartu identitas seperti KTP, SIM. b. Pasien yang pembayaran dengan jaminan harus membawa rujukan dari faskes pertama seperti puskesmas/dokter keluarga/faskes I/dokter praktek swasta/RS 2. Pasien BPJS PBI/ BPJS Non PBI: a. Pasien rujukan faskes I/puskesmas/ RS b. Kartu BPJS c. KTP/KK 3. Pasien baru: Persyaratan seperti diatas 4. Pasien lama: Kartu kontrol dari RSUD Dr. Soetomo 5. Persyaratan masuk RS Instalasi graha Amerta: a. KTP, KK, dan Kartu Berobat b. Surat pengantar MRS c. Rujukan dari Faskes dengan tujuan RSUD Dr. Soetomo (khusus pasien JKN Kelas I) d. Melakukan registrasi rawat jalan untuk mendapatkan SEP rawat jalan (khusus pasien JKN Kelas I)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Rawat Jalan: a. Pasien dan keluarga masuk melalui pintu utama dan disambut oleh petugas. Apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda/<i>brandcart</i>. Dan petugas siap membantu ke poli klinik tanpa dipungut biaya. b. Pasien dan keluarga mengambil nomer di TPP (Tempat Pendaftaran Pasien) mandiri. c. Pasien dan keluarga langsung ke pendaftaran. d. Pasien dan keluarga dipanggil berdasar nomer urut pendaftan e. Pasien umum/mandiri mendapatkan billing untuk membayar di kasir/bank JATIM f. Pasien menuju klinik yang dituju g. Pasien akan dilakukan pelayanan medik dan keperawatan

		h. Pasien dapat resep dan pulang i. Pasien konsul ke poliklinik lain atau periksa laborat/radiologi j. Pasien yang konsul membawa hasil konsul/laborat/radiologi ke poli awal k. Pasien pulang/masuk RS 2. Pasien Rawat Inap: a. Pasien MRS/rawat inap membawa pangantar rawat inap ke admisi b. Pasien MRS diantar petugas ke tempat rawat inap beserta pangantar rawat inap dari admisi
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Rawat Jalan/Poliklinik Spesialis: a. Senin - Jumat: 08.00 - 14.00 b. Sabtu - Minggu: sesuai perjanjian c. Hari Libur Nasional: Libur 2. Klinik Medik Dasar: Setiap hari 24 jam. 3. Rawat Inap: Buka setiap hari 24 jam.
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Poliklinik Spesialis: a. Kesehatan Anak b. Bedah Anak c. Bedah Jantung d. Bedah Plastik e. Bedah Saraf f. Bedah Urologi g. Gigi dan Mulut h. Mata i. Paru j. Jiwa k. Saraf l. THT m. Jantung dan Pembuluh Darah n. Bedah Thoraks o. Bedah Kepala/Leher p. Ortopedi dan Traumatologi q. Penyakit Dalam

		r. Kulit dan Kelamin s. Kandungan dan Kebidanan t. Rehabilitasi Medik u. Tumbuh Kembang Anak 2. Klinik Medik Dasar 3. Rawat Inap di Instalasi Graha Amerta: a. <i>President suite</i> b. <i>Premium suite</i> c. VVIP A d. VVIP B e. VIP
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1. Website/SANDI: https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 2. Facebook: RSUD Dr. Soetomo 3. Twitter: @rsudrsoetomo 4. Instagram: @rsudrsoetomo 5. Customer care: 031-5020599 6. Frontdesk (24 jam): 031-5013484, 5012195 Ext 2000 7. Poli Spesialis: 031-5022911
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 3. Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. 4. Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 5. Permenkes No. 30 tahun 2020 Kualifikasi Perijinan Rumah Sakit.
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tempat pendaftaran pasien 2. Ruang tunggu: kursi, TV, fotocopy, AC kipas angin, tulisan petunjuk nomor antrian 3. Poliklinik: alkes, ATK, komputer, mikrofon. 4. Ruang pembayaran 5. Anjungan pendaftaran mandiri dan online 6. Kursi roda dan brandcart 7. Ruang Rawat Inap: a. Tempat Tidur Pasien b. Tempat Tidur Penunggu c. Kamar Mandi: Air Panas/Dingin d. AC - Sofa - TV

		e. Ruang Keluarga f. Pantry g. Makan Pasien Dan Penunggu Pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis 2. Dokter umum khusus Klinik Medik Dasar 3. Perawat, bidan, fisioterapi, ahli gizi, psikolog a. Tenaga non medis b. IPMS c. Transporter d. Cleaning service
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
11	Jumlah Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Monev Standar Pelayanan Minimal dilakukan setiap bulan 2. Monev pelayanan dilakukan setiap bulan 3. Penilaian kinerja dokter perawat dilakukan 1 bulan sekali 4. Laporan hasil pelayanan dilakukan 1 tahun sekali

4. PELAYANAN JANTUNG TERPADU

No	Aspek	Penjelasan
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan	A. Pasien Umum/Mandiri: 1. Pasien datang di pendaftaran dengan membawa kartu identitas seperti KTP, SIM. 2. Pasien yang pembayaran dengan jaminan harus membawa rujukan dari faskes pertama seperti puskesmas/dokter keluarga/faskes I/dokter praktek swasta/RS B. Pasien BPJS PBI/ BPJS Non PBI: 1. Pasien rujukan faskes I/puskesmas/ RS 2. Kartu BPJS/JKN 3. KTP/KK C. Pasien baru : Persyaratan seperti diatas D. Pasien lama: Kartu kontrol dari RSUD Dr. Soetomo
2	Prosedur Pelayanan Pasien	1. Pelayanan pasien kardiovaskular di PPJT RSUD Dr Soetomo dapat berasal dari pasien umum, asuransiperusahaan, dan BPJS sertadibedakan menjadi tiga golongan, yaitu pasien emergensi, pasien rawat inap, dan pasien rawat jalan. 2. Pasien emergensi yang masuk ke PPJT bisa berasal dari UGD PPJT dan IRD RSUD dr. Soetomo. 3. Pasien rawat jalan dapat berasal dari IRJ RSUD dr. Soetomo dan URJ PPJT. 4. Pasien rawat inap RSDS dapat dikonsultasikan untuk mendapat pelayanan di PPJT, dan kemungkinan menjalani rawat inap atau apabila diperlukan dapat dirawat di ruang ICCU atau intermediate atau bahkan bila diperlukan dapat dilakukan tindakan di <i>Cathlab</i>-OK PPJT. 5. Pasien dapat langsung mendapat perawatan baik di ICCU, Intermediet, maupun rawat inap. Pasien setelah mendapat perawatan ICCU selanjutnya masuk ke rawat inap terlebih dulu sebelum <i>ambulator</i> /rawat jalan.
3	Waktu Pelayanan	a. Pelayanan rawat inap 24 jam b. Pelayanan kegawatdaruratan kardiovaskular 24 jam c. Pelayanan kamar operasi elektif pukul 08.00 - selesai d. Pelayanan poliklinis : • Hari senin -kamis pukul 08.00- - 14.00

		• Hari Jumat pukul 08.00- -14.00 • Hari sabtu, minggu dan libur nasional tutup
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	- Poliklinik rawat jalan VIP dan non VIP baik dewasa maupun anak - Layanan pemeriksaan kardiovaskular non invasif meliputi Rekam Jantung 24 jam (<i>Holter monitoring</i>), <i>Ambulatory Blood Pressure Monitoring</i>, <i>Exercise (Treadmill dan Ergocycle) Stress Test</i>, <i>X-Ray</i>, <i>Echocardiography</i> dan <i>USG Vascular</i>. - Layanan Diagnostik Invasif (kateterisasi) - Layanan bedah jantung dewasa dan anak - Layanan kamar operasi hybrid - Layanan prevensi dan rehabilitasi kardiovaskuler - Layanan rawat inap dewasa dan anak - Layanan ruang intermediate dan intensif - Layanan Laboratorium - Layanan Farmasi - Ballroom/ruang pertemuan
6	Aduan / Saran / Masukan	1. Website/SANDI https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 2. Facebook RSUD Dr. Soetomo 3. Twitter @rsudrsoetomo 4. Instagram @rsudrsoetomo 5. Telp: 031-55011316
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	- Undang Uundang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang -Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. - Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. - Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. - Permenkes No. 30 tahun 2020 Kualifikasi Perijinan Rumah Sakit.
8	Sarana dan Prasarana	Ruang ruang poliklinik rawat jalan dan <i>medical check up</i> untuk penyakit kardiovaskular dengan fasilitas VIP dan non VIP.

		b. Pemeriksaan kardiovaskular non invasif meliputi Rekam Jantung 24 jam (Holtermonitoring), Ambulatory BloodPressure Monitoring, Exercise(Treadmill dan Ergocycle) Stress Test, X-Ray , Echocardiography dan USGVascular. c. Ruang rawat inap d. Ruang perawatan intermediate dan intensif e. Ruang kateterisasi f. Ruang operasi g. Ruang operasi hybrid h. Ruang kateterisasi i. Ruang pemeriksaan radiologi j. Ruang kantor k. Ballroom l. Ruang tunggu pasien + musholla + Toilet m. Ruang Dokter Jaga.
9	Kompetensi Petugas	1. Kepala Instalasi : Dokter Spesialis/S2(BLS/ACLS, PPI) 2. Wakil Kepala Instalasi : DokterSpesialis/S2 (BLS/ACLS, PPI) 3. Koordinator Pelayanan dan Rekam Medik: Dokter Spesialis/S2 (BLS/ACLS,PPI) 4. Koordinator Keperawatan : SIKeperawatan (BLS, K3RS, PPI) 5. Koordinator Penunjang Medik: Dokter Spesialis/S2 (BLS/ACLS) 6. Koordinator Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan : Dokter Spesialis/S2 (BLS,PPI, GCP) 7. Koordinator Umum dan Rumah Tangga : DIII Tehnik (BLS, K3RS) 8. Penanggung Jawab Unit Pelayanan : Dokter Spesialis/S2 (BLS/ACLS, PPI) 9. Penanggung Jawab Unit Keperawatan: SI/DIII Keperawatan (BLS/ACLS, PPI,K3RS) 10.Penanggung Jawab Unit Penunjang : Dokter, Apoteker, 11.Nakes lain : BLS, K3RS 12.Perawat Pelaksana : SI/DIII Keperawatan (BLS/ACLS, PPI,K3RS) 13.Administrasi : DIII Rekam medis/ SIAdministrasi 14.RS (BLS, K3RS)
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

11	Pelaksana	a. Kelompok Staf Medis sesuai jenis Spesialisasi b. Keperawatan c. Petugas Laboratorium d. Petugas Radiologi e. Transporter
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monev Standar Pelayanan Minimal dilakukan setiap bulan 2. Monev pelayanan dilakukan setiap bulan 3. Penilaian kinerja dokter perawat dilakukan 1 bulan sekali 4. Laporan hasil pelayanan dilakukan 1 tahun sekali

5. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Aspek	Penjelasan
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan Pelayanan/ prosedur Pendaftaran Pasien Rawat Inap	1. Persyaratan pendaftaran: - Pasien Umum KTP/KK/Paspor - Pasien Penjaminan - KTP/KK/Paspor - Identitas Penjaminan Pasien - Surat rujukan dari puskesmas / dokter keluarga / RSUD (kecuali pasien masuk rumah sakit melalui IGD) 2. Prosedur Pendaftaran - Petugas Admisi rawat inap memberi salam dan melayani pasien atau keluarga pasien sesuai dengan nomor antrian pendaftaran - admisi melakukan verifikasi data pasien sesuai dengan identitas pasien dan melakukan entry di SIMRS - petugas admisi rawat inap menjelaskan kelas perawatan beserta tarif dan fasilitasnya - petugas admisi meminta pasien menyerahkan kelengkapan persyaratan pendaftaran (lihat poin 1) - petugas admisi menginput data sosial pasien sesuai dengan KTP/KK/Paspor ke dalam SIMRS - Petugas admisi rawat inap melihat ketersediaan tempat tidur pada SIMRS dan menelepon ruangan yang dituju untuk konfirmasi ketersediaan tempat tidur - petugas admisi mencetak barcode identitas pasien - petugas admisi mencetak gelang identitas pasien - petugas pendaftaran rawat inap mengarahkan pasien untuk membaca hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien pada media informasi rumah sakit - petugas admisi meminta pasien / keluarga pasien mengisi data dan menandatangani formulir persetujuan umum saat MRS / General consent.
2	Sistem Mekanisme dan	1. Menerima surat pengantar dari poliklinik yang dibawa petugas atau pasien/keluarga pasien

	Prosedur Pelayanan	2. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas ruang perawatan 3. Memperhatikan surat jaminan seperti BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaan, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dll 4. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien/keluarganya yang memerlukan 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di ruang rawat inap yang bersangkutan untuk memastikan tempat pasien dirawat 6. Pasien lama/pasien yang sudah pernah berobat dilihat KIB pasien tersebut, apabila tidak dibawa dapat dicari di komputer untuk memastikan nomor rekam medis lama 7. Pasien baru dibuatkan KIB untuk menentukan nomor rekam medis pasien tersebut 8. Data pasien di input berdasarkan kartu identitas (KTP, SIM, atau pasport) 9. Entry data ke simrs dilakukan berdasarkan surat pengantar rawat inap, kemudian pencetakan lembar masuk dan surat eligibilitas pasien 10. Surat jaminan dirawat di kelas ditandatangani oleh pasien/walinya atau yang menjamin 11. Membuat berkas rekam medis pasien 12. Menyerahkan berkas rekam medis pasien 13. Memberikan informasi kepada keluarga pasien yang bertanya dimana ruang pasien dirawat 14. Melakukan konfirmasi dengan piket keperawatan bila ruangan penuh untuk mendapatkan kamar inap
--	--------------------	---

3	Waktu Pelayanan	Pendaftaran pasien rawat inap - Input data 1 menit - Pencetakan SEP rawat inap 1 menit Penjelasan general consent, tarif ruangan, tindakan, hak dan kewajiban pasien 3-5 menit - Mencari kamar 3-5 menit - Pembuatan berkas rekam medis 5 menit Catatan : waktu ini tidak termasuk apabila ruangan penuh Lokasi Admisi Portal admisi pasien rawat inap di RSUD Dr. Soetomo ada di 4 (empat) area, yaitu: a. Admisi rawat inap I berlokasi di GPDT/GDC lantai 1 yang mengakomodasi pasien yang akan rawat inap elektid yang masuk melalui rawat jalan dan pasien emergensi yang masuk melalui IGD. b. admisi rawat inap II berlokasi di PPJT lantai 1 yang mengakomodasi pasien yang akan rawat inap elektif dan emergensi di Gedung PPJT c. Admisi rawat inap III berlokasi di Instalasi Graha Amerta lantai dasar mengakomodasi pasien yang akan rawat inap elektif dan emergensi di Instalasi Graha Amerta. d. Admisi rawat inap IV berlokasi di lantai 1 RIK 7 yang kana mengakomodasi pasien rawat inap di Instalasi P3RPM Waktu Pelayanan Setiap hari, 24 jam.
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	a. Pelayanan Rawat Inap Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 1) Rawat Inap Medik 2) Rawat Inap Obsgyn 3) Rawat Inap Anak 4) Rawat Inap Jiwa 5) Rawat Inap Bedah b. Pelayanan Rawat Inap Kelas Utama Graha Amerta

		1) VIP 2) VVIP 3) Premium Suite 4) President Suite c. Rawat Inap Isolasi Infeksius d. Pelayanan Intermediate / HCU / HDC / Recovery Room / RR e. Pelayanan Intensive Care Unit, ICCU, NICU, PICU, dan Burn Unit
6	Aduan / Saran / Masukan	1. Website/SANDI https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 2. Facebook RSUD Dr.Soetomo 3. Twitter @rsudrsoetomo 4. Instagram @rsudrsoetomo 5. Telp: 031-55011316
B	Manufacturing	
7	Dasar Hukum	• Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. • Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. • Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. • Permenkes No. 30 tahun 2020 Kualifikasi Perijinan Rumah Sakit.
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu pasien + musholla + Toilet 2. Ruang Admisi. 3. Loker Administrasi. 4. Ruang Farmasi 24 jam. 5. Bank Darah. 6. Sarana <i>hand washing</i> dan <i>hand rub</i> . 7. Ruang Kantor. 8. Nurse Station. 9. Ruang Dokter Jaga.

9	Kompetensi Petugas	1. Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) 2. Perawat/ bidan dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) 3. Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Rehabilitasi Medik, Psikolog Klinis) dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Pelaksana	1. Kepala Instalasi 2. MPP 3. Kepala Ruangan 4. Dokter 5. Perawat 6. Farmasi/Apoteker/AA/TTK 7. Gizi 8. CSSD 9. Perekam Medis 10. Staf administrasi 11. Teknisi 12. Petugas Pengambil Contoh 13. Transporter 14. Pramubakti 15. Cleaning Service
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien.

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Pelaporan	Laporan Bulanan 1. Laporan Jumlah Kunjungan 2. Laporan Indikator Kinerja Rawat Inap 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4. Laporan Kepuasan Pelanggan 5. Laporan Indikator Mutu Unit 6. Laporan Insiden 7. Laporan Vaksin Bayi Hb (khusus ruang bayi IRNA Obgyn)
----	--	--

6. PELAYANAN BEDAH PUSAT

No	Aspek	Penjelasan
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan	1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi 2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan 3. Kartu BPJS 4. Kartu identitas (KTP/ SIM/ Pasport)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap 2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi 3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif / terjadwal) 4. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima 5. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi 6. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan 7. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang
3	Waktu Pelayanan	Hari Kerja & Jam Kerja: • Hari operasional yang berlaku untuk kamar operasi elektif adalah 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. • Sistem kerja di Instalasi Bedah Pusat adalah sistem kerja dengan 2 (dua) shift, dengan jam kerja sebagai berikut : ○ Shift I : Pk 07.00 – 15.30 wib ○ Shift II : Pk 13.00 – 21.00 wib
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	Pelayanan Tindakan Operasi
6	Aduan/Saran/Masukan	1. Website/SANDI https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 2. Facebook RSUD Dr.Soetomo 3. Twitter @rsudrsoetomo

		4. Instagram @rsudrsoetomo 5. Telp: 031-5501875
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	• Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. • Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. • Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. • Permenkes No. 30 tahun 2020 Kualifikasi Perijinan Rumah Sakit
8	Sarana dan Prasarana	1. LANTAI GROUND – GBPT Meliputi ruang transfer yaitu ruang ganti dan persiapan untuk pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, ruang ganti petugas, ruang petugas IPSM dan ruang informasi. 2. LANTAI 1 – GBPT Meliputi unit pelayanan farmasi, ruang logistik, ruang linen dan ruang sterilisasi. 3. LANTAI 2 – GBPT Meliputi ruang ICU, ICCU dan NICU 4. LANTAI 3 – GBPT Meliputi ruang pulih sadar dan burn unit. 5. LANTAI 4 – AREA KAMAR OPERASI IBP (GBPT) Meliputi Ruang premedikasi dan 8 ruang operasi, yang terdiri dari : 1. OK 403 : Bedah Digestif 2. OK 405 : Bedah Anak 3. OK 406 : Onkologi 4. OK 408 : Bedah Plastik 5. OK 409 : Common Use / Bedah Mulut 6. OK 411 : Common Use / Bedah Plastik 7. OK 412 : Endo - Urologi 8. OK 414: Urologi

		6. LANTAI 5 – AREA KAMAR OPERASI IBP (GBPT) Meliputi Ruang premedikasi dan 8 ruang operasi, yang terdiri dari : 1. OK 503 : Mata 2. OK 505 : Common Use / Mata 3. OK 506 : Common Use / Obsgyn 4. OK 508 : Obsgyn 5. OK 509 : THT 6. OK 511 : Common Use / THT 7. OK 512 : Bedah Kepala Leher 8. OK 514 : Laparascopy – Endoscopy 7. LANTAI 6 – AREA KAMAR OPERASI IBP (GBPT) Meliputi ruang premedikasi dan 6 ruang operasi yang terdiri dari : 1. OK 603 : Common Use (Bedah Saraf / Bedah TKV) 2. OK 607 : Bedah Saraf 3. OK 609 : Bedah TKV 4. OK 610 : Common Use / Orthopaedi 5. OK 612 : Common Use / Orthopaedi 6. OK 614 : Orthopaedi & Traumatologi
9	Kompetensi Petugas	• Dokter Spesialis Bedah dari berbagai KSM • Dokter Subspesialis • Dokter Spesialis Anestesi • Kepala Instalasi • Koordinator Keperawatan • Ka. Ruangan/ PJ Lantai • Perawat Bedah • Perawat/Penata Anestesi • Radiografer • Administrasi • Pramu Bakti
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat RSUD Dr Soetomo :

		Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku kami siap menerima sanksi
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien.
13	Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Pelaporan	• Evaluasi kinerja berdasarkan indikator mutu nasional dan indikator mutu lokal. • Data indikator mutu dikolekting (entry) oleh champion mutu yang di validasi oleh kepala ruangan tiap 3 bulan. • Data indikator mutu dikumpulkan setiap bulan ke Komite Mutu Dan Keselamatan Pasien dan Instalasi Bedah Sentral. • Data Indikator mutu dilakukan analisis • Indikator mutu yang tidak mencapai target atau mengalami penurunan yang signifikan perlu dilakukan perbaikan dengan siklus PDCA (FOCUS PDCA atau PDCA tulta) oleh Instalasi bersama ruang rawat inap. • Capaian indikator mutu menjadi dashboard unit kerja dan Instalasi.

7. PELAYANAN LABORATORIUM SENTRAL

No	Aspek	Penjelasan
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan Pelayanan/ prosedur Pendaftaran Pasien Laboratorium Sentral	a. Baik pasien rawat jalan/inap/gawat darurat dan baik pasien umum/BPJS/IKS, DPJP harus melakukan permintaan pemeriksaan melalui aplikasi <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP b. Spesimen rujukan: - SHK → Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengisian data pasien di aplikasi SWALAB, spesimen dikirim melalui kurir dengan melampirkan rekap data spesimen - HIV-Viral Load -EID → Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengisian data pasien di aplikasi kemenkes, spesimen dikirim melalui kurir dengan melampirkan rekap data spesimen - Patologi anatomi → membawa voucher dan surat keterangan dari dokter, kemudian petugas loket di GPDT melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP - GeneXpert MDR/XDR TB → Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengisian data pasien di Aplikasi Kemenkes (SITB), specimen dikirim melalui kurir dengan melampirkan rekap data spesimen.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	PREANALITIK 1. Pasien Rawat Jalan a. DPJP melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP b. Pada pemeriksaan Patologi Klinik yang CITO, spesimen diambil di Kamar 14 dan dikirim ke lantai 1 GPDT (Ruang Sampling) untuk klik terima spesimen c. Pemeriksaan Patologi klinik non CITO spesimen diambil ke lantai 1 GPDT (Ruang Sampling) d. Pengambilan spesimen pemeriksaan Patologi anatomi-FNAB dilakukan di GPDT lantai 6 e. Pengambilan spesimen pemeriksaan Patologi anatomi-core biopsi dilakukan di GPDT lantai 1 ruang CT Scan

No	Aspek	Penjelasan
		f. Pengambilan sampel pemeriksaan MDR TB dilakukan di Poli DOT MDR TB g. Pada pemeriksaan Mikrobiologi Klinik pengambilan sampel dari pasien Poli dilakukan di Ruang Sampling GPDT Lt. 1 2. Pasien Rawat Inap a. DPJP melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP b. Pada pemeriksaan Patologi Klinik POCT, spesimen diambil dan analisa di ruang rawat inap oleh perawat ruangan. Hasil dimasukkan di SIMPP c. Pemeriksaan Patologi klinik non CITO spesimen diambil oleh perawat dan dikirim ke GPDT lantai 4 melalui aerocom d. Pengambilan spesimen Mikrobiologi klinik dilakukan oleh perawat dan diantar ke loket Mikrobiologi Klinik GPDT Lt. 1 e. Pengambilan spesimen patologi anatomo dilakukan dokter bedah dan dikirim ke GPDT lantai 6 oleh kurir 3. Pasien Gawat Darurat a. DPJP melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP b. Pada pemeriksaan Patologi Klinik tertentu, spesimen diambil dan analisa di IGD oleh ATLM c. Pemeriksaan Patologi klinik non CITO spesimen diambil oleh perawat dan dikirim ke GPDT lantai 4 melalui aerocom d. Pengambilan spesimen Mikrobiologi Klinik dari IGD dan OK IGD dilakukan oleh perawat dan diantar ke loket Mikrobiologi Klinik GPDT Lt. 1 4. Spesimen rujukan a. SHK → Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengisian data pasien di aplikasi SWALAB, spesimen dikirim melalui kurir dengan melampirkan rekap data spesimen b. HIV-Viral Load -EID → Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengisian data pasien di aplikasi kemenkes, spesimen dikirim melalui kurir dengan melampirkan rekap data spesimen

No	Aspek	Penjelasan
		c. Patologi anatomi → membawa voucher dan surat keterangan dari dokter, kemudian petugas loket di GPDT melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP d. GeneXpert MDR/XDR TB → Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengisian data pasien di Aplikasi Kemenkes (SITB), specimen dikirim melalui kurir dengan melampirkan rekap data spesimen. Rekap Data dimintakan No. RM melalui ARINA (Administrasi Rawat Inap), kemudian petugas melakukan penginputan melalui SIMPP. ANALITIK a. Proses analitik pemeriksaan patologi klinik dilakukan di GDC lantai 4 b. Proses analitik pemeriksaan Mikrobiologi Klinik dilakukan di GDC lantai 5 c. Proses analitik pemeriksaan patologi anatomi dilakukan di GDC lantai 6 POST ANALITIK a. Hasil diverifikasi secara online oleh DPJTM di LIS b. Bila ditemukan nilai kritis, maka dilaporkan sesuai dengan standar IPSG 2.1
3	Waktu Pelayanan	a. Pelayanan di RSUD Dr. Soetomo dilaksanakan pada hari kerja (Senin-Jumat), sedang untuk pemeriksaan emergensi dan pemeriksaan tertentu dilayani selama 24 (Dua Puluh Empat) jam setiap hari. b. Pemeriksaan tertentu yang dilayani selama 24 (Dua Puluh Empat) jam setiap hari adalah semua pemeriksaan Patologi Klinik, semua Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik (pengobatan sediaan, kultur), Pemeriksaan Biomolekuler (RT PCR)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik 2. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Aspek	Penjelasan
		3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
6	Aduan / Saran / Masukan	1. Website/SANDI https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 2. Facebook RSUD Dr. Soetomo 3. Twitter : @rsudrsoetomo 4. Instagram : @rsudrsoetomo 5. No. Telp IGD : 0315501299
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit 4. Permenkes Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit 5. Permenkes Nomor 1691/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit 6. Kepmenkes Nomor 363/Menkes/PER/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan 7. Kepmenkes RI Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik 8. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No 188.4/5962/301/2018 tentang Kebijakan Pelayanan Diagnostik dan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo 9. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No 188.4/4826/301/2018 tentang Kebijakan Instalasi Laboratorium Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo.
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruangan Laboratorium Patologi Klinik 2. Ruangan Laboratorium Patologi Anatomi 3. Ruangan Laboratorium Mikrobiologi Klinik

No	Aspek	Penjelasan
9	Kompetensi Petugas	a. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik b. Dokter Spesialis Patologi Klinik c. Dokter Spesialis Patologi Anatomi d. tenaga kesehatan lain (analisis) yang memiliki kompetensi di bidangnya dan mempunyai Surat Penugasan dari Direktur RSUD Dr. Soetomo.
10	Struktur Organisasi laboratorium dan Kualifikasi	1. Kepala Instalasi Laboratorium Sentral - Dr. HARTONO dr.,SpPK.,MQIH 2. Koordinator Mutu-Yulia Nadar Indrasari dr. SpPK 3. Koordinator Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan-dr. RIDHOLIA, Sp.PA 4. Koordinator Pelayanan-M. Robiul Fuadi, dr. Sp, PK (K) 4.1. sub Koordinator Pelayanan Patologi Klinik-dr. Dwi Rahayuningsih, Sp.PK 4.2. Sub Koordinator Pelayanan Mikrobiologi Klinik-dr. Siti Rochmanah Oktaviani Sulikah, M.Ked.Klin, Sp.MK 4.3. Sub Koordinator Pelayanan Patologi Anatomi-Heriyawati,dr.,Sp.PA(K) 4.4. Sub Koordinator Pelayanan Biomolekuler-dr. Alicia Margaretta Widya, M.Ked.Klin., Sp.MK (K) 4.5. Sub Koordinator Pelayanan BSL 2-Munawaroh Fitriah, dr. Sp.PK 4.6. Sub Koordinator Pelayanan BSL 3-dr. Neneng Dewi Kurniati, Sp. MK 5. Koordinator Sekretariat-Etty Hary Kusumastuti dr., Sp.PA(K), MIAC 5.1. sub Koordinator Sumber Daya Manusia-Lavatini,SKM 5.2. Sub Koordinator Sarana Prasarana Dan Logistik-dr. Priangga Adi Wiratama, Sp.PA 5.3. Sub Koordinator Pelayanan Pre Dan Post-dr. Naritha Vermasari, Sp.MK (K)
11	Pengawasan Internal	a. Pengawasan oleh atasan langsung b. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
12	Pelaksana	a. Kelompok Staf Medis sesuai jenis Spesialisasi b. ATLM c. Transporter

No	Aspek	Penjelasan
13	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien.
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Pelaporan	a. Laporan SPM b. Laporan indikator mutu Patologi Klinik, Patologi Anatomi dan Mikrobiologi Klinik c. Laporan evaluasi CDC d. Laporan evaluasi pelayanan e. Laporan evaluasi TAT f. Laporan evaluasi KSO

8. PELAYANAN RADIOLOGI

No	Aspek	Penjelasan
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan Pelayanan/ prosedur Pendaftaran Pasien Radiologi	1. Baik pasien rawat jalan/inap/gawat darurat dan baik pasien umum/BPJS/IKS, DPJP harus melakukan permintaan pemeriksaan melalui aplikasi <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP 2. Pemeriksaan radiologi yang menggunakan anastesi: a. Membutuhkan pemeriksaan laboratorium berupa BUN dan Kreatinin-serum. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut harus ada H-1 sebelum pemeriksaan radiologi b. Membutuhkan penjadwalan radiologinya yang dilakukan hari Kamis (anak-anak) dan selain hari Kamis (dewasa) c. Membutuhkan EWO anastesi yang dilakukan oleh poli dokter umum di GPDT lantai 1 3. Pemeriksaan radiologi dengan kontras membutuhkan: Resep obat kontras dari DPJTM 4. Pemeriksaan radiologi yang membutuhkan penjadwalan dilakukan secara digital oleh radiologi membutuhkan pendaftaran oleh pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien Rawat Jalan a. DPJP melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP b. Pemeriksaan Radiologi elektif dilayani Radiologi GDC Lt 1 dan 2 c. Pemeriksaan radiologi yang terjadwal dilakukan sesuai jadwal . d. Hasil Pemeriksaan dapat dilihat oleh pasien melalui aplikasi SIPS 2. Pasien Rawat Inap a. DPJP melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP b. Pada pemeriksaan Citobed Ruangan anak COVID (Nicu dan Picu) dan COVID Radiografer melakukan Bed Foto di ruang rawat inap. Hasil dapat dilihat melalui EMR.

No	Aspek	Penjelasan
		c. Pada pemeriksaan Radiologi yang terjadwal dilakukan sesuai jadwal pasien rawat inap. Hasil dapat dilihat melalui EMR. 3. Pasien Gawat Darurat a. DPJP melakukan permintaan pemeriksaan melalui <i>electronic work order</i> (EWO) di SIMPP b. Pada pemeriksaan radiologi emergency dilakukan di Unit radiologi IGD. Hasil dapat dilihat melalui EMR. ➤ Hasil diverifikasi secara online oleh DPJTM di SIMPP ➤ Bila ditemukan nilai kritis, maka dilaporkan sesuai dengan standar IPSPG 2.1
3	Waktu Pelayanan	Pelayanan radiologi di RSUD Dr. Soetomo dilaksanakan pada hari kerja (Senin-Jumat), sedang untuk pemeriksaan emergensi dan pemeriksaan tertentu dilayani selama 24 (Dua Puluh Empat) jam setiap hari terutama di IGD
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Karcis Rp45.000,-
5	Produk Layanan	X-ray Konvensional Non Thorax GDC X-ray Thorax GDC X-ray Konvensional Non Thorax IGD X-ray Thorax IGD CT Scan GDC & PPJT CT Scan IGD CT Kepala CT Abdomen CT Thorax CT Ekstremitas Mammografi USG GDC USG IGD: Usg Fast Usg Non Fast MRI

No	Aspek	Penjelasan
		Panoramic (Gigi) Bone Densitometri (DXA)
6	Aduan / Saran / Masukan	1. Website/SANDI https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id 2. Facebook RSUD Dr. Soetomo 3. Twitter : @rsudrsoetomo 4. Instagram : @rsudrsoetomo 5. No. Telp IGD : 0315501299
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit 4. Permenkes Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit 5. Permenkes Nomor 1691/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit 6. Kepmenkes Nomor 363/Menkes/PER/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan 7. Kepmenkes RI Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik 8. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No 188.4/5962/301/2018 tentang Kebijakan Pelayanan Diagnostik dan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo
8	Sarana dan Prasarana	Ruang radiologi
9	Kompetensi Petugas	a. Dokter Spesialis radiologi b. tenaga kesehatan lain (radiografer) yang memiliki kompetensi di bidangnya dan mempunyai Surat Penugasan dari Direktur RSUD Dr. Soetomo.

No	Aspek	Penjelasan
10	Struktur Organisasi radiologi dan Kualifikasi	1. Kepala Instalasi Radiologi - HARTONO YUDI SARASTIKA dr.,SpRad (K) 2. Koordinator Sekretariat dan SDM - BUDI PRIJO WITJAKSONO., SST. 3. Koordinator Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan- LENNY VIOLETTA dr.,SpRad (K) 4. Koordinator Pelayanan - DIAN NURHAYATI, dr., SpRad (K) 4.1 Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Logistik – FIRDAUS HERMADONA, Amd Rad 4.2 Sub Koordinator Mutu Pelayanan IGD – HIDAYAT SURYA ATMAJA, dr.,SpRad (K) a) Penanggung Jawab CT Scan – ACHMAD BUDI ARYONO, SST b) Penanggung Jawab MRI – SAMSUL HUDHA, SST c) Penanggung Jawab KN – STEPHANUS MASSORA , dr.,Sp.KN d) Penanggung Jawab USG – SRI YULIATI, Amd.Rad e) Penanggung Jawab IGD – PRAMONO, SST f) Penanggung Jawab Flouroskopi & Angiografi – MADE ANGGA CAHYADI, Amd Rad g) Penanggung Jawab Konvensional 1 – NUR HALIMAH SUKRON , Amd Rad h) Penanggung Jawab Konvensional 2 – PUTRI VALERIA OKTAVERA , Amd Rad i) Penanggung Jawab PPJT – YOGI KURNIA RACHMAWAN , SST j) Penanggung Jawab GBPT & IBP – ARIEF RAHMAN, SST k) Penanggung Jawab GRAHA & IIU – CATUR YUNI ROMADHANI, Amd.Rad l) Penanggung Jawab Citobed - UMAR Amd.Rad m) Penanggung Jawab Loker - WINARTI
11	Pengawasan Internal	a. Pengawasan oleh atasan langsung b. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
12	Pelaksana	a. Kelompok Staf Medis sesuai jenis Spesialisasi b. Radiographer

No	Aspek	Penjelasan
		c. Transporter
13	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien.
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Pelaporan	1. Laporan SPM 2. Laporan indikator mutu radiologi 3. Laporan evaluasi CDC 4. Laporan evaluasi pelayanan 5. Laporan evaluasi TAT 6. Laporan evaluasi KSO

9. PELAYANAN FARMASI

No	Aspek	Penjelasan
A	<i>Service Delivery</i>	
1	Persyaratan Pelayanan Resep	1. Pelayanan Resep Rawat Jalan - Pasien membawa kartu pasien (kartu kuning); - Pasien dengan penjamin asuransi statusnya harus aktif; - Pasien melakukan pemeriksaan dengan dokter; - Dokter membuat resep elektronik melalui WO Resep di <i>Electronic Medical Record</i> (EMR) atau menulis resep; - Khusus di di UPF Rawat Jalan Terpadu, Pasien mengambil nomor antrian di Unit Pelayanan Farmasi dan menunggu antrian obat; - Untuk Poli yang masih menggunakan resep manual, pasien menyerahkan resep ke petugas farmasi; - Persyaratan khusus lainnya: ✓ Pasien penyakit kronis: hasil pemeriksaan penunjang (khusus hasil penunjang dari luar RSDS); ✓ Pasien kemoterapi: membawa kartu kendali obat dan hasil pemeriksaan penunjang (khusus hasil penunjang dari luar RSDS); ✓ Pasien Tuberkulosis (TB): membawa kartu TB-01; untuk pasien anak membawa buku kontrol poli respirologi. ✓ Pasien dengan <i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i> (CAPD): untuk pasien baru wajib membawa KTP, KK dan SEP (untuk pasien JKN). 2. Pelayanan Resep Rawat Inap: - Pasien Masuk Rumah Sakit dengan membawa kartu JKN, rujukan dari Faskes, surat pengantar Masuk Rumah Sakit (MRS) dari dokter - Dokter membuat resep elektronik melalui WO Resep di <i>Electronic Medical Record</i> (EMR) atau menulis resep - Untuk ruangan yang masih menggunakan resep manual, pasien menyerahkan resep ke petugas farmasi:

		- Persyaratan khusus lainnya: ✓ Pasien penyakit kronis: hasil pemeriksaan penunjang (khusus hasil penunjang dari luar RS Dr. Soetomo); ✓ Pasien kemoterapi: a) Resep kemoterapi b) Form retriksi c) Hasil Patologi Anatomi d) Hasil Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan khusus hasil dari luar RS Dr. Soetomo: misalnya CT Scan, USG, Foto Thorax dll e) Surat pengantar Masuk RS dari Dokter ✓ Pasien Tuberkulosis (TB): membawa kartu TB-01; untuk pasien anak membawa buku kontrol Poli Respirologi. ✓ Pasien dengan <i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i> (CAPD): pasien baru wajib membawa KTP, KK dan SEP (untuk pasien JKN)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Resep	1. Pelayanan Resep Rawat Jalan Dokter menanyakan Riwayat pengobatan pasien dan melakukan pencatatan Riwayat pengobatan pasien di Asesmen Awal Medis a. Dokter menulis resep dan instruksi pengobatan secara manual atau secara elektronik b. Tenaga kefarmasian menerima resep dan melakukan telaah serta membandingkan dengan Riwayat pengobatan pasien c. Tenaga Kefarmasian menyiapkan obat dan/atau alat kesehatan d. Tenaga kefarmasian melakukan telaah obat e. Tenaga kefarmasian memberikan edukasi kepada pasien / keluarga pasien f. Tenaga kefarmasian melakukan serah terima obat kepada pasien / keluarga pasien 2. Pelayanan Resep Rawat Inap a. Dokter melakukan rekonsiliasi terapi b. Dokter menulis resep dan instruksi pengobatan secara manual atau secara elektronik

		c. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) melakukan rekonsiliasi dan Serah Terima Obat d. Tenaga Kefarmasian menerima resep, melakukan verifikasi instruksi pengobatan pada RPO/lembar perawatan intensif, serta melakukan telaah e. TTK menyiapkan obat / alkes secara <i>Unit Dose Dispensing</i> (UDD). Apabila pasien masuk ruang rawat inap di luar jam pelayanan farmasi di ruangan, TTK menyiapkan obat / alkes (obat dilayani hingga pelayanan farmasi di ruangan buka) f. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) melakukan telaah obat g. TTK melakukan serah terima obat/alkes kepada perawat atau kepada keluarga pasien ,kecuali obat <i>High Alert</i> hanya diperbolehkan diserahkan kepada petugas Kesehatan. h. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) memberikan edukasi kepada pasien terkait obat pada RM 6 (Catatan Informasi dan Edukasi Terintegrasi) i. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) menyiapkan obat/alkes untuk pasien KRS berdasarkan instruksi pengobatan yang ditulis dokter pada resep dan resume medis 3. Pelayanan Resep Ruang Operasi a. Dokter / perawat mengajukan permintaan obat / alkes sesuai jenis dan jumlah beserta kelengkapan data pasien ke Tenaga Teknis Kefarmasian dengan mengisi form obat / alkes Bedah / Anestesi.
--	--	--

		b. Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian OK melakukan verifikasi terhadap permintaan obat / alkes, untuk alkes yang mempunyai restriksi khusus dan memerlukan persetujuan manajemen maka menunggu disposisi jawaban dari manajemen untuk melayani permintaan. c. Tenaga Teknis Kefarmasian OK menyiapkan jumlah dan jenis obat/alkes sesuai dengan yang diminta d. Tenaga Teknis Kefarmasian melakukan serah terima obat / alkes dengan dokter atau perawat Bedah / Anestesi Jika ada tambahan disaat operasi berlangsung, Tenaga Teknis Kefarmasian menambahkan catatan permintaan dalam form obat / alkes Bedah / Anestesi sesuai dengan jumlah dan jenis yang diberikan e. Setelah selesai operasi, dokter / perawat mengembalikan sisa obat/alkes yang tidak digunakan pasien f. Tenaga Teknis Kefarmasian memeriksa kembali sisa obat/ alkes yang tidak digunakan pasien g. Dokter memverifikasi obat / alkes yang digunakan dengan menandatangani form obat / alkes, serta membuatkan resep untuk pemakaian implan. h. Tenaga Teknis Kefarmasian melakukan entry data sesuai jumlah obat / alkes yang digunakan pasien i. Tenaga Teknis Kefarmasian memeriksa kembali kelengkapan daftar lembar Bedah/ Anestesi meliputi identitas pasien, tanda tangan dokter / perawat Bedah / Anestesi dan Tenaga Teknis Kefarmasian										
3	Waktu Pelayanan	c. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan <table><tr><th>UNIT / UPF</th><th>JAM PELAYANAN</th></tr><tr><td rowspan="3">UPF RAWAT JALAN TERPADU</td><td>Senin - Kamis pk. 07.00 - 15.00</td></tr><tr><td>Jumat pk. 07.00 - 15.30</td></tr><tr><td>Sabtu pk. 08.00 - 15.00</td></tr><tr><td>UPF POSA</td><td>Senin - Jumat pk. 07.30 - 15.30</td></tr><tr><td>UPF MDR TB</td><td>Senin - Sabtu pk. 07.00 - 15.00</td></tr></table>	UNIT / UPF	JAM PELAYANAN	UPF RAWAT JALAN TERPADU	Senin - Kamis pk. 07.00 - 15.00	Jumat pk. 07.00 - 15.30	Sabtu pk. 08.00 - 15.00	UPF POSA	Senin - Jumat pk. 07.30 - 15.30	UPF MDR TB	Senin - Sabtu pk. 07.00 - 15.00
UNIT / UPF	JAM PELAYANAN											
UPF RAWAT JALAN TERPADU	Senin - Kamis pk. 07.00 - 15.00											
	Jumat pk. 07.00 - 15.30											
	Sabtu pk. 08.00 - 15.00											
UPF POSA	Senin - Jumat pk. 07.30 - 15.30											
UPF MDR TB	Senin - Sabtu pk. 07.00 - 15.00											

		UPF UPIPI		Senin - Sabtu pk. 08.00 - 15.00
		UPF HEMODIALISA		Senin - Sabtu pk. 08.00 - 15.00
		UPF PALIATIF		Senin - Kamis pk. 07.00 - 15.00
				Jumat pk. 07.00 - 15.30
		UPF GRIU STOC		Senin - Sabtu pk. 07.00 - 21.00
		UPF PPJT		Senin - Jumat pk 07.00 - 17.00
				Sabtu - Minggu pk. 08.00 - 15.00
		UPF GPDT		Senin - Jumat pk. 07.00 - 15.00
		UPF Bedah (IIU)		Senin - Jumat pk. 07.00 - 15.00
		d. Pelayanan Farmasi Rawat Inap		
		UNIT / UPF	JAM	NO.TELPON
		UPF Medik	Buka 24 jam	031-5501377
		UPF Anak	Buka 24 jam	031-5501581
		UPF Bedah	Buka 24 jam	031-5501782
		UPF Obgyn	Senin - Sabtu pk. 07.00 - 20.00	031-5501758
			Minggu pk. 08.00 -15.00	
		UPF GRIU STOC	Buka 24 jam	031-5502155 Ext.2107-2108
		UPF GBPT	Buka 24 jam	031-5501815
		UPF IGD	Buka 24 jam	031-5501231
		UPF PPJT	Senin - Jumat pk. 06.00 - 21.00	031-5501441
			Sabtu - Minggu pk. 08.00 - 15.00	031-5501602
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		

5	Produk Layanan	1. Pelayanan Perbekalan Farmasi Individual 2. Pelayanan Perbekalan Farmasi Unit Dose Dispensing (UDD) 3. Pelayanan Perbekalan Farmasi Paket Operasi 4. Pelayanan Perbekalan Farmasi Paket Hemodialisa 5. Pelayanan Dispensing Sediaan Steril (IV admixture, Handling Sitostatika, Sediaan Nutrisi Parenteral) 6. Pelayanan Radiofarmaka 7. Pelayanan Produksi Farmasi (Ekstrak Alergen, Triple Dye)
6	Aduan / Saran / Masukan	a. Website/SANDI https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id b. Facebook :RSUD Dr. Soetomo c. Twitter : @rsudrsoetomo d. Instagram : @rsudrsoetomo e. No. Telp call center Farmasi :
B	<i>Manufacturing</i>	
7	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. <i>Permenkes</i> Nomor 72 Tahun 2016 Tentang <i>Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</i> d. <i>Permenkes</i> Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit e. <i>Permenkes</i> Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit f. <i>Permenkes</i> Nomor 1691/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit g. <i>Peraturan</i> Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian h. <i>Keputusan</i> Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor 188.4/5962/301/2018 tentang Kebijakan Pelayanan Diagnostik dan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo i. <i>Keputusan</i> Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor 188.4/4021/102.6/2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo

		j. <i>Keputusan</i> Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor 188.4 / 4719.1 / 102.6 / 2023 tentang Kebijakan Struktur Organisasi, Pejabat Dan Uraian Tugas Pejabat Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Tahun 2022
8	Sarana dan Prasarana	a. Unit Pelayanan Farmasi Rawat Jalan (data terlampir) • UPF Rawat Jalan Terpadu • UPF Posa • UPF MDR TB • UPF UPIPI • UPF HEMODIALISA • UPF Paliatif • UPF GRIU STOC • UPF PPJT • UPF GDC • UPF Bedah (IIU) b. Unit Pelayanan Farmasi Rawat Inap (data terlampir) • UPF Medik • UPF Anak • UPF Bedah • UPF OBGYN • UPF GRIU STOC • UPF GBPT • UPF IGD • UPF PPJT c. Gudang Farmasi (data terlampir) d. Unit Dispensing Sediaan Farmasi (data terlampir) e. Unit Laboratorium Farmasi (data terlampir)
9	Kompetensi Petugas	a. Apoteker Spesialis Farmasi Rumah Sakit Jumlah 11 orang b. Apoteker Magister Farmasi Klinis Jumlah 19 orang c. Apoteker Magister Non Farmasi Klinis Jumlah 2 orang d. Apoteker Jumlah 39 orang e. Tenaga Teknis Kefarmasian jumlah 236 orang

10	Struktur Organisasi Instalasi Farmasi dan Kualifikasi	Mengacu SOTK Instalasi Farmasi yang terbaru (data terlampir) Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor 188.4/8487.1/102.6/2023 tentang Penetapan Jabatan Koordinator, Kepala Unit / Unit Pelayanan Farmasi (UPF) dan Penanggung Jawab di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Jabatan Dalam Struktur Organisasi : 1. Koordinator Pengelolaan Perbekalan Farmasi (Dra. Worokarti, SpFRS, Apt) 2. Koordinator Farmasi Klinik (Drs. Muhammad Yahya, SpFRS, Apt) 3. Koordinator Monitoring Evaluasi dan Penjaminan Mutu (Mariyatul Qibtiyah, S.Si, SpFRS, Apt) 4. Koordinator Kesekretariatan, Umum dan Sarana Prasarana (Drs. Sujatno, Apt)
11	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
12	Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Petugas Pengambil Contoh (PPC) 4. Pengadministrasi Umum
13	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat RSUD Dr. Soetomo.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien.
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Pelaporan	a. Laporan SPM (data terlampir) b. Laporan indikator mutu Instalasi Farmasi (data terlampir) c. Laporan kinerja Pelayanan Farmasi (Pengelolaan Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Farmasi Klinis) (data terlampir)

B. Pola Pelayanan

1. Pola Pelayanan Fungsional: Pola pelayanan fungsional merupakan pola pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Hal ini dapat dilaksanakan di tiap instalasi pelayanan yang ada di RSUD Dr. Soetomo.
2. Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap: Pola pelayanan yang diselenggarakan di RSUD Dr. Soetomo merupakan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Satu Pintu yaitu Pola Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan pada satu tempat terdiri dari berbagai jenis pelayanan yang ada dan memiliki keterkaitan proses, dan dilayani melalui satu pintu.

C. Komponen Standar Pelayanan

1. Komponen Standar Penyampaian (*service delivery*) Pelayanan Publik
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
 - c. Jangka Waktu Penyelesaian
 - d. Biaya/Tarif Pelayanan
 - e. Produk Pelayanan
 - f. Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan
Pengaduan, Saran, dan Masukan terkait pelayanan di RSUD Dr. Soetomo dapat melalui laman web resmi maupun sosial media yang dikelola oleh Bagian Humas Rumah Sakit.
2. Komponen Standar Proses Pengelolaan (*manufacturing*) Pelayanan Publik
 - a. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas
 - b. Kompetensi Pelaksana
Tenaga Kesehatan pelaksana pemberi pelayanan dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) sesuai dengan kompetensinya yaitu dokter, perawat, bidan dan farmasi serta ditunjang profesi lain seperti radiografer, analis lab, tenaga sanitarian, dan lain lain
 - c. Pengawasan Internal
Pengawasan internal di RSUD Dr. Soetomo secara rutin dilakukan oleh unit SPI (satuan pengendali internal). RSUD Dr. Soetomo terus melakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan ikut serta dalam akreditasi standar kesehatan dan standar JCI edisi 7.
 - d. Jumlah Pelaksana Internal
 - e. Jaminan Pelayanan
Jaminan Pelayanan menggunakan JKN - KIS dan beberapa asuransi swasta
 - f. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - g. Evaluasi Kinerja Pelayanan

D. Maklumat Pelayanan



The image shows a formal document titled "MAKLUMAT PELAYANAN RSUD Dr. SOETOMO". At the top, there are several logos including the official emblem of RSUD Dr. Soetomo, a circular logo with a star, a gold coin-like logo, a green logo with a heart, and two red logos with the text "BerAKHLAK" and "bangga melayani bangsa". Below the logos, the title "MAKLUMAT PELAYANAN RSUD Dr. SOETOMO" is centered. Under the title, there are three numbered points in Indonesian:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan

Below the points, there is a date and location "Surabaya, 2 Januari 2024" and the name "Direktur RSUD Dr. Soetomo". A large, circular official stamp of RSUD Dr. Soetomo is placed over the signature area. Below the stamp, the name "Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, dr." is written, followed by her qualifications "Sp.DVE, Subsp.DAI.FINS-DV,FAADV.,MARS.". Below this, it says "Pembina Utama Muda" and "NIP. 19670804 199703 2 002". At the bottom, the text "RSUD Dr. SOETOMO BUILD TRUST" is visible.

E. Sikap dan Perilaku

Pengelola dan pemberi pelayanan publik di RSUD Dr. Soetomo wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut:

1. Jujur, disiplin, dan profesional.
2. Adil dan non diskriminatif.
3. Peduli, teliti, dan cermat.
4. Ramah, sopan, dan santun.
5. Tegas dan tidak memebrikan pelayanan yang berbelit-belit.
6. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun di luar regulasi yang ada.
7. Perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat.

F. Pelayanan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya yang ditempuh oleh RSUD Dr. Soetomo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pimpinan dan pelaksana pelayanan selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien sesuai dengan visi dan misi RSUD Dr. Soetomo.
2. Penetapan Surat Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Publik yang menjadi acuan untuk pemberian pelayanan publik di RSUD Dr. Soetomo.
3. Penetapan Panduan Praktek Klinis (PPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pada setiap unit pelayanan.

4. Pemberi Pelayanan yang terdiri dari tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya diwajibkan mempunyai sertifikasi untuk memberikan pelayanan di RSUD Dr. Soetomo sesuai dengan kompetensi masing-masing.
5. Pendidikan dan Pelatihan dilakukan untuk seluruh tenaga pemberi pelayanan sesuai dengan kompetensinya.
6. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan selalu difasilitasi atau dilengkapi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
7. Informasi tentang pelayanan yang dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh masyarakat.
8. Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan secara rutin untuk mengevaluasi berbagai hal dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD Dr. Soetomo.
9. Evaluasi oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP) terhadap berbagai indikator mutu pelayanan di tiap unit pelayanan.
10. Mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat dan tanggapan terhadap pengaduan tersebut.

G. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hal yang setiap tahun dilakukan di lingkungan RSUD Dr. Soetomo dalam rangka pengelolaan kepuasan secara berkelanjutan. Hal tersebut bukanlah sekadar untuk memenuhi kewajiban yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, melainkan juga ditujukan untuk mendapatkan data dan pengetahuan mengenai instalasi-instalasi mana saja yang telah berhasil mencapai pelayanan yang prima.

Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

RSUD Dr. Soetomo pernah tersertifikasi ISO 9001:2008, dimana salah satu persyaratan ISO 9001:2008 adalah memonitor persepsi pelanggan tentang kemampuan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan mereka sekaligus mengetahui penyebab utama kepuasan/ketidakpuasan pelanggan. Saat ini, RSUD Dr. Soetomo telah terakreditasi secara internasional, selain akreditasi nasional yaitu KARS, melalui akreditasi JCI (*Joint Commission International*). Status pencapaian akreditasi tersebut menegaskan bahwa komitmen RSUD Dr. Soetomo senantiasa mengarahkan agar pelayanan kesehatan rumah sakit berfokus kepada pasien dan diterapkan sesuai dengan budaya setempat untuk peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu bagi RSUD Dr. Soetomo untuk terus mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat pada instalasi-instalasi yang berada di bawah naungannya. Selain pengukuran IKM yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, sebagaimana disyaratkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, jajaran manajemen RSUD Dr. Soetomo juga memandang perlu untuk memahami pergerakan kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu, sehingga bisa melakukan evaluasi dan tindakan-tindakan pengelolaan secara lebih cepat dan tanggap.

Oleh karena itu, selain pengukuran IKM tahunan, juga dilaksanakan monitoring pencapaian pelayanan melalui survei periodik per tiga bulan melalui pengukuran *Net Promoter Score* (NPS). Inovasi tersebut dilakukan sebagai ikhtiar untuk mengakselerasi pencapaian pelayanan superior (*superior service performance*) kepada para pelanggan.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diperoleh di RSUD Dr. Soetomo didasarkan pada unsur-unsur yang ada di dalam PERMENPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ke-9 (Sembilan) variabel tersebut adalah: Persyaratan Pelayanan; Prosedur Pelayanan; Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan Sarana dan Prasarana.

1. Persyaratan pelayanan: adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian: adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif: adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana: adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana: adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan ini terhadap pelayanan yang telah diberikan. Indeks ini digunakan sebagai tolak ukur dari kualitas pelayanan RSUD Dr. Soetomo, apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah diisyaratkan oleh pemerintah.

Kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kualitas pelayanan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan, dimulai dengan menganalisis setiap item atau sub unsur yang ada dalam setiap unsur. Setiap item dalam satu unsur dianalisis, kemudian skor keseluruhan item dalam satu unsur tersebut dicari rata-ratanya untuk menganalisis kualitas dari kinerja setiap unsur. Setelah semua unsur diukur baru kemudian total skor keseluruhan dari unsur yang ada dalam penelitian ini dicari rata-ratanya untuk menentukan IKM di RSUD Dr. Soetomo.

Pengukuran kualitas pelayanan di RSUD Dr. Soetomo, dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden eksternal (baik pasien Umum, pasien BPJS dan pasien peserta asuransi lainnya) maupun kepada responden internal RS (karyawan RSUD Dr. Soetomo yang menggunakan jasa pada instalasi tersebut). Mereka diminta untuk mengisi kuesioner sesuai dengan pendapat masing-masing responden tentang pelayanan yang diterimanya.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Dr. Soetomo tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hasil penilaian *Net Promoter Score* (NPS) untuk keseluruhan responden pada instalasi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan total akhir NPS positif ($58,18 - 4,91 = 53,27$). Hasil NPS yang positif mengindikasikan para responden loyal terhadap layanan yang diberikan RSUD Dr. Soetomo dan masih akan memanfaatkan layanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo untuk kedepannya.
2. Secara global keseluruhan instalasi, responden menilai pelayanan yang diberikan memiliki kategori Sangat Baik (Mean score 3,54; nilai IKM 88,42).
3. Dari 9 (sembilan) indikator yang diamati, secara keseluruhan unit/instalasi yang disurvei, secara umum mayoritas indikator menunjukkan penilaian responden "Sangat Baik", dengan indikator Perilaku Petugas mendapatkan penilaian 188 tertinggi (MS 3.65, IKM 91,17) disusul Kompetensi Petugas (MS 3.65, IKM 91,13). Sedangkan indikator yang mendapatkan nilai terendah adalah Penanganan Pengaduan dengan "Baik" (MS 3.28, IKM 82,11).
4. Kecenderungan kenaikan IKM yang juga selaras dengan nilai NPS mengindikasikan adanya keterkaitan (korelasi) antara kepuasan dan loyalitas pelanggan.

H. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerima Pelayanan

1. Hak Pasien:

Setiap pasien mempunyai hak:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Kewajiban Pasien:

Dalam menerima pelayanan di Rumah Sakit, setiap pasien mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
3. Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit ;
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya;
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

3. Tanggung Jawab Pasien:

1. Mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan keputusan mengenai perawatan kesehatan pasien;
2. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kesehatan dan riwayat kesehatan pasien, termasuk kondisi sekarang, penyakit masa lalu, riwayat rawat inap dan pengobatan;
3. Mendiskusikan masalah perawatan kesehatan, kekhawatiran dan kebutuhan pribadi pasien dengan penyedia layanan kesehatan secara jujur dan memberi tahu penyedia layanan kesehatan tentang setiap perubahan yang terjadi pada kesehatan pasien;
4. Memastikan pasien bebas narkoba dan alkohol. Pasien yang diyakini berada dibawah pengaruh hal tersebut wajib ditangani oleh ketentuan yang berlaku;
5. Bekerja sama dengan semua petugas kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien dan berperilaku sopan dan saling menghormati;
6. Menghormati hak penyedia layanan kesehatan dan untuk bertukar informasi dengan cara yang baik dan tidak melakukan kekerasan, secara fisik maupun verbal saat dalam perawatan;
7. Mengikuti intruksi asuhan kesehatan atau memberi tahu staf kami jika pasien tidak dapat atau tidak bersedia mengikuti rencana asuhan;
8. Menerima konsekuensi karena menolak rencana asuhan atau tidak mengikuti rencana asuhan;

9. Menghormati hak dan privasi semua profesional pemberi asuhan, karyawan rumah sakit, dan pasien lain;
10. Memberitahu staf rumah sakit bila merubah keputusan persetujuan atas rencana asuhan yang telah disetujui.

I. Kendali Mutu Pelayanan

Penyelenggara Pelayanan Publik di RSUD Dr. Soetomo menyusun kebijakan dan standar pelayanan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang aman, terstandar, dan menjamin kepuasan pasien. Selain itu pemantauan mutu pelayanan dan keselamatan pasien juga dilaksanakan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, yang dilakukan oleh oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP).

J. Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. Soetomo, diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai sarana telekomunikasi dan informasi. Berbagai informasi tersebut bisa diakses melalui akun resmi web RSUD Dr. Soetomo, dan media sosial lainnya seperti instagram, facebook, dan lain-lain.

II. PENUTUP

Akuntabilitas dan transparansi, adalah dua hal yang diupayakan untuk selalu ditingkatkan dalam pengelolaan pelayanan publik. Hanya dengan cara tersebut pemerintah dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan standar pelayanan di setiap unit penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan salah satu jembatan yang dapat mempertemukan harapan masyarakat dan kesanggupan penyedia pelayanan. Melalui standar pelayanan penyedia pelayanan berjanji untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan jika suatu instansi memiliki standar pelayanan. Manfaat ini tentu saja dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik masyarakat maupun bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Selain itu masyarakat akan mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggung-jawabkan serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.

Bagi organisasi standar pelayanan merupakan alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat sarana monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. Adanya standar pelayanan,

memungkinkan adanya perbaikan kualitas atau mutu pelayanannya secara berkelanjutan (continuous improvement). Karena dengan adanya standar pelayanan organisasi dapat terus menerus memperbaiki pelayanannya dari aspek persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya. Standar pelayanan juga mensyaratkan adanya pengelolaan pengaduan yang merupakan wadah bagi mekanisme umpan balik dari masyarakat, sehingga birokrasi dapat lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana dan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.

Uraian dalam buku ini memberikan petunjuk praktis mengenai hal-hal apa yang harus dipersiapkan serta langkah-langkah dalam merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan standar pelayanan. Terdapat syarat utama bagi keberhasilan penerapan standar pelayanan yaitu perubahan paradigma birokrasi yang harus menempatkan rakyat dan kepentingannya sebagai fokus utama dari pelayanan yang diselenggarakannya.

Standar Pelayanan Publik yang disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Beberapa tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik antara lain:

- a. Keramahan dari penyedia layanan;
- b. Waktu pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat dan akurat;
- c. Sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan;
- d. Sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain.

Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien secara cepat dan transparan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi instansi penyelenggara pelayanan khususnya untuk RSUD Dr. Soetomo Surabaya secara internal yang akan menyusun, mengimplementasikan, dan memperbaiki standar pelayanannya. Karena bagaimanapun pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan yang memang mensyaratkan agar setiap instansi penyelenggara pelayanan memiliki sebuah standar pelayanan. Dengan demikian diharapkan penyusunan buku ini memberikan kontribusi nyata bagi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik.